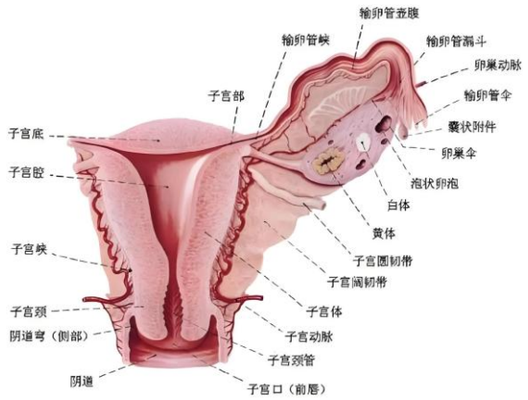
核心精讲·生殖系统疾病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



宫颈阴道部-鳞状上皮 如果其变成柱状上皮,则为化生

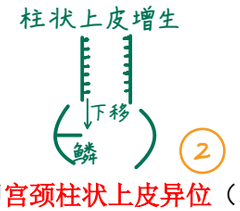
宫颈管-柱状上皮 如果柱状上皮下移到阴道部,只是位置改变,不叫化生

一、宫颈疾病

（一）慢性宫颈炎

（1）宫颈**息肉**（好慢吶米西）①

慢性炎症长期刺激,增生以后形成息肉

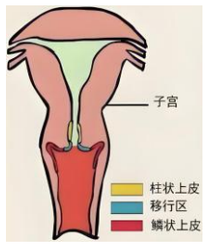


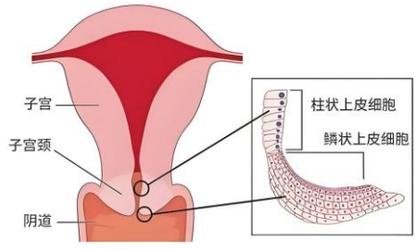
（2）**假性宫颈糜烂**

①雌激素使宫颈管柱状上皮增生下移到达宫颈阴道部，即**宫颈柱状上皮异位**（不是柱状上皮化生），由于柱状上皮较薄、上皮下血管较易显露而呈红色，加之柱状上皮呈乳头状突起、肉眼看起来好像发生了糜烂（不是真的糜烂-糜烂指上皮坏死脱落形成的浅表缺损），此为正常的生理现象（不是病）ttsx *VS Barrett食管(柱状上皮化生)*

VS 上皮坏死脱落形成深的缺损为溃疡

②异位的柱状上皮在阴道酸性环境刺激下发生**鳞状上皮化生**（鳞状上皮替代柱状上皮），形成新的鳞-柱状上皮交界处





（3）**纳博特囊肿**：新生的鳞状上皮覆盖阻塞子宫颈管腺体开口→粘液潴留在腺管内 ③



① 理顺知识点：

本质上是慢性炎症导致慢性增生,形成息肉,是一种慢性非特异性增生性炎。

“不要看到息肉就想到癌”

② 理顺知识点：

注意此处教材改版。宫颈的阴道部本身被覆鳞状上皮,在雌激素的作用下,宫颈管被覆的柱状上皮下移,到宫颈阴道部。

此时由于鳞状上皮本身较厚,而柱状上皮较薄,导致上皮下血管透见,从而使其显露红色,且柱状上皮本身呈乳头状突起,最终形似糜烂,但没有上皮细胞的缺损,称为假性糜烂。(以前认为是柱状上皮化生,现在认为是柱状上皮异位)

随后,异位的柱状上皮在阴道酸性环境的刺激下,化生为鳞状上皮。(即先异位后化生)

注意区分两个不同的病理过程,历年真题此处答案为化生,以题带动天天师兄讲的知识点复习。

③ 理顺知识点：

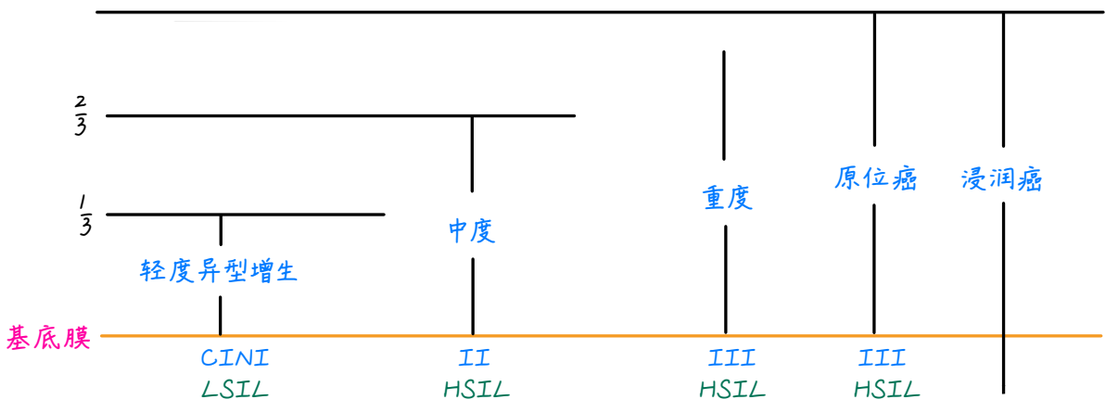
新生的鳞状上皮(非柱状上皮)覆盖阻塞子宫颈管的腺体开口,影响腺体的正常分泌黏液。黏液潴留在腺管内,导致腺体扩大,此时扩大形成的囊肿称为纳博特囊肿。(如图示)

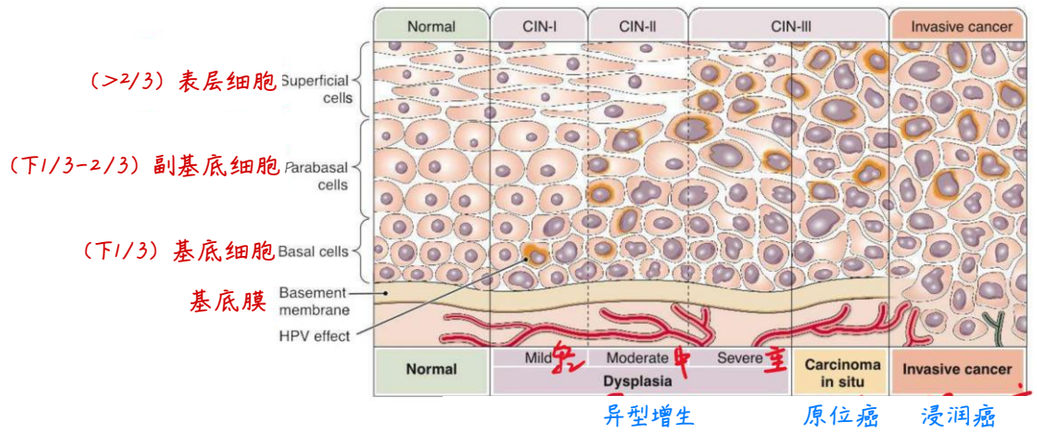
（二）宫颈癌

1.**癌前病变：宫颈鳞状上皮内病变**，即子宫颈上皮部分被不同程度异型性的细胞取代，出现**挖空细胞**或鳞状上皮细胞**异型增生**。低级别鳞状上皮内病变 LSIL 常可消退

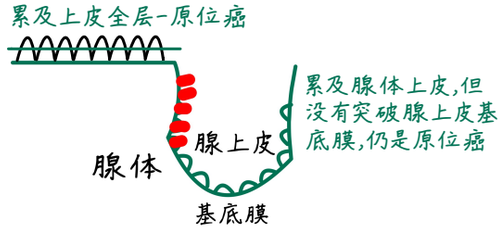
HPV　　癌前病变:发展成为癌的概率大,不是一定变成癌

鳞状上皮内病变 SIL	上皮内瘤变 CIN	鳞状上皮范围	细胞异型显著 可见核分裂象
随访即可低级别 LSIL low	I级	下 1/3	轻度异型增生
高级别 HSIL high	II级	下 2/3	中度异型增生
处理方法相同	III级	下 2/3 以上或全层 （但未突破基底膜）	重度异型增生和原位癌 可见病理性核分裂象





注意：异型细胞可由表面沿基底膜通过子宫颈腺口蔓延至子宫颈腺体内、取代部分或全部腺上皮，但仍未突破腺体的基底膜，称为 CIN III累及腺体



④ 理顺知识点：
不是所有的癌前病变都有异型增生,如肝硬化是原发性肝癌的异型增生,但其肝细胞再生无异型性。
但是,有异型增生的一定是癌前病变。注意逻辑关系。

注意教材改版,最新说法是宫颈鳞状上皮内病变(以前称为上皮内瘤变),其中挖空细胞是HPV感染的特点。

⑤ 理顺知识点：
此处的分型建议看图理解,病变是从基底膜开始的,由下往上发展。
此时向上发展,分为轻度、中度、重度。
当累及全层时,称为原位癌。向下突破基底膜时,称为浸润癌。

2.病因：**人乳头瘤病毒 HPV** 尤其 **16、18** 型

抑癌基因(基因组卫士)

①HPV 编码的 E_6 蛋白使 ***p53*** 失活、E_7 蛋白使 ***RB*** 失活（5678）⑥

②免疫组化 p16 弥漫强阳性可辅助诊断 HSIL（p16 蛋白是高危型 HPV 基因表达的指标）

16、18型HPV基本上引起的都是高级别

3.**鳞**癌最常见 宫颈与摩擦有关

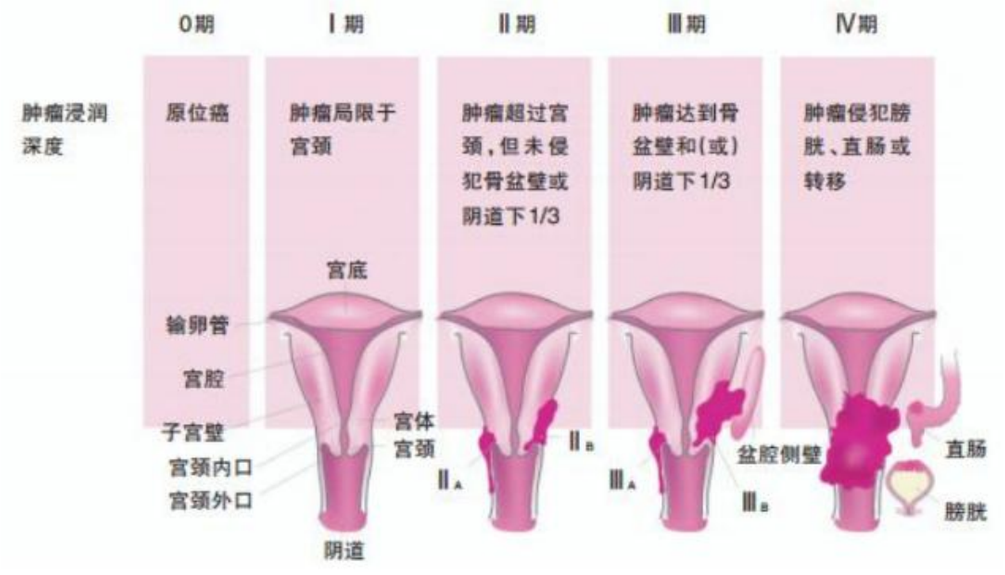
4.好发于**鳞-柱状上皮交界处（移行带）**。若 HPV 感染原始的鳞-柱状上皮交界处则与化生无关；若 HPV 感染新的鳞-柱状上皮交界处则与化生有关 ⑦

慢性宫颈炎柱状上皮异位到宫颈阴道部,由于不耐受酸性环境发生鳞化而形成

5.最早和最常见扩散：淋巴转移（最早转移至子宫旁淋巴结）和直接蔓延

6.临床分期（**0 期-原位癌**）

I	癌局限于子宫颈内 ①早期/微小浸润癌：浸润深度≤基底膜下 **5**mm ⑧ ②浸润癌：浸润深度＞基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3（阴字偏旁像 3；删我）
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠



⑥ 理顺知识点：

HPV编码的蛋白质,具有使抑癌基因失活的作用。当原癌基因-抑癌基因的平衡被打破后,则出现癌变。

⑦ 理顺知识点：

宫颈癌是否与化生有关,取决于发病部位。如发病于原始鳞状-柱状上皮交界处,其本身是鳞状上皮,则发生鳞癌,此时与化生无关。

若其发生于新形成的鳞状-柱状上皮交界处,其本身为柱状上皮,在阴道酸性环境下化生为鳞状上皮,则与化生有关。

⑧ 理顺知识点：

宫颈癌的分期,于10版教材中,关于宽度7mm的知识点已删除。考研复习紧跟天天师兄所讲知识点,以题带动天天师兄讲过的知识点进行复习,是效率最高的方法,大多数同学无需自己扩展。

VS 病理诊断肺心病的关键:肺动脉瓣下2cm处,右心室前壁肌层厚度超过5mm

二、宫体疾病

（一）子宫内膜异位症 ⑨

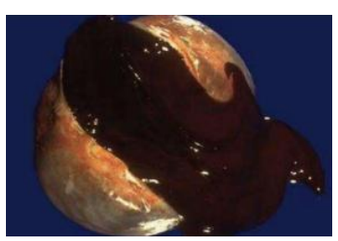
①子宫内膜腺体和间质出现在子宫内膜以外的部位。若异位于子宫肌层（且距离子宫内膜基底层 2mm 以上）称为**子宫腺肌病/瘤**

出现类似肿瘤样结构

②**卵巢（最常见）**、子宫阔韧带等

③受 ttsx 卵巢分泌激素的影响，异位的子宫内膜产生周期性反复出血，导致卵巢体积增大、形成囊腔，囊内含粘稠的咖啡色样液体（**陈旧血液**），称为**巧克力囊肿**

受到卵巢分泌激素影响也可出现月经,但月经排不出去



（二）子宫内膜增生症 VS 子宫内膜腺癌:有无子宫内膜间质浸润

①**雌激素**↑致子宫内膜腺体或间质增生（增生期与雌激素有关）

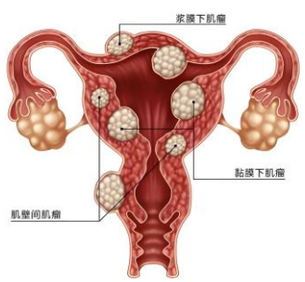
②病理变化

增生细胞与原来正常细胞一样

	增生不伴不典型性 （包括以前的单纯性增生、复杂性增生）	**异型增生** **（不典型增生）**
发展为 子宫内膜为腺上皮 **子宫内膜腺癌**几率	1-3%	**1/3**
腺体增多	可背靠背 （腺体排列拥挤致腺体与腺体相邻）	**明显背靠背** ⑩ **无子宫内膜间质浸润** **（区别于癌）**

（三）子宫平滑肌瘤

（1）肿瘤可位于黏膜下、肌层、浆膜下、子宫腔、宫颈口外，以**肌层**最常见



⑨ 理顺知识点:

子宫内膜异位症的定义是子宫内膜腺体和间质出现在子宫内膜以外的部位,而不是子宫以外的部位。

故若其子宫内膜腺体和间质出现在子宫肌层(且要求距离子宫内膜基底层2mm以上)依然属于子宫内膜异位症,此时称为子宫腺肌病,或子宫腺肌瘤。

注意,有"瘤"字样的不一定是肿瘤,只是形态学的描述。

⑩ 理顺知识点:

子宫内膜异型增生此时为子宫内膜腺癌的癌前病变,但还不是癌,因此无子宫内膜间质浸润(若发展为子宫内膜腺癌,才浸润子宫内膜间质)。

规律：良性肿瘤有包膜

（2）子宫平滑肌瘤虽为良性肿瘤、但无包膜，瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈旋涡/编织/束状排列

特殊 (11)

良性肿瘤一般规律：细胞异型性小，组织异型性大
恶性肿瘤组织异型性和细胞异型性均很大

异型性 [组织：排列方式不同 / 细胞：跟正常细胞长的不一样

（3）子宫平滑肌瘤的肌瘤变性

①玻璃样变/透明变性（最常见）：漩涡状结构由透明样物质取代

②红色变性（妊娠期多见）：肌瘤间质血管血栓形成致局部坏死、出血

恶性肿瘤命名规则：恶性肿瘤来自上皮组织（黏膜被覆上皮等）-癌

(12) 恶性肿瘤来自间叶组织-肉瘤　间叶：去掉皮肤、神经剩下的都是间叶组织，如脂肪、结缔组织、血管、淋巴管、骨头、软骨等

注意：子宫平滑肌肉瘤——肿瘤边界不清、细胞异型显著、核分裂象增多（主要）

VS 乳腺大量淋巴细胞浸润的髓样癌的边界清楚

肝癌多结节型通常可以看到界限比较清楚的癌结节→肝癌界限清楚

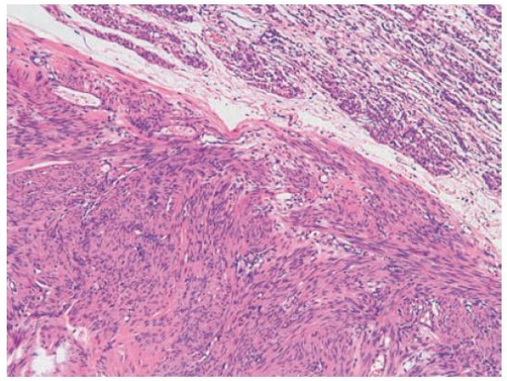


图 14-8　子宫平滑肌瘤
瘤细胞束状或旋涡状排列，瘤细胞呈长梭形，肿瘤组织与周围正常组织境界清楚（100 倍）。

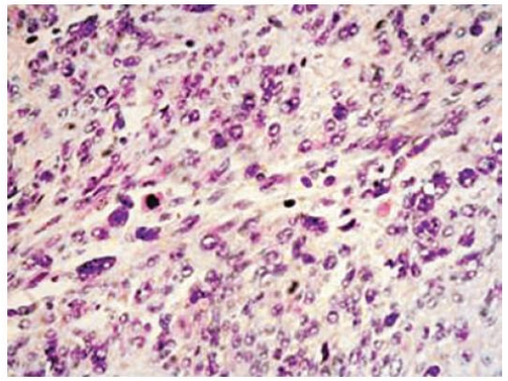


图 14-9　子宫平滑肌肉瘤
瘤细胞密集呈梭形或椭圆形，大小不等、形状不一，可见核分裂象。

(11) 理顺知识点：
学习技巧，抓规律记特殊。良性肿瘤一般都有包膜保护（规律），但子宫平滑肌瘤是良性肿瘤但无包膜（特殊）。

(12) 理顺知识点：
组织分为上皮组织、神经组织和间叶组织。除去上皮组织和神经组织，其余都是间叶组织，包括骨、软骨、脂肪、肌肉、淋巴造血组织、结缔组织等。

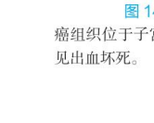
三、滋养细胞疾病

滋养细胞疾病的**共同特征**是**滋养层细胞异常增生**，人绒毛膜促性腺激素 **hCG** 含量高于正常妊娠

滋养细胞疾病包括：　良性

葡萄胎	完全性、部分性、侵袭性 交界性
肿瘤	绒毛膜癌、胎盘部位滋养细胞肿瘤、上皮样滋养细胞肿瘤
非肿瘤性病变	
异常绒毛病变	

（一）葡萄胎 VS 绒癌

	良性葡萄胎（完全性、部分性）	交界性恶性葡萄胎（侵袭性葡萄胎）	绒毛膜癌/绒癌（多继发于完全性葡萄胎）
两种滋养层细胞			
(13) 合体滋养层细胞增生 细胞滋养层细胞增生	√	比 良性葡萄胎 显著	比 侵袭性葡萄胎 显著
程度不同 滋养层细胞 异型增生、坏死出血	轻度		
间质	间质水肿 血管消失		无间质和血管 血管消失 ✗ 绒癌无血管、那怎么获取营养啊？不用你操心，绒癌侵袭宿主血管、直接泡在母体血管，是最易血道转移的癌
绒毛 	√	√	× 恶性程度高 （异型性大-分化低） 三无产品：鱼香肉丝没有鱼、老婆饼没有老婆 ttsx 绒毛是正常结构 绒癌无绒毛 说明与正常结构差别大
侵犯子宫肌层 和或血管	×	√（水泡状绒毛侵入子宫肌层）	√ 癌细胞直接侵入子宫肌层 （但无水泡状绒毛）
阴道蓝紫色结节	×	(14) √	√
转移	×	几乎× 交界性-生物学行为介于良恶性之间	√ (15) 侵犯子宫静脉-压力低 血道转移：肺最常见→咯血 原发灶切除后转移灶可自行消退 恶性肿瘤最大特点-转移 淋巴转移 ✗
主要治疗	彻底清宫	化疗	化疗 (16)

注意：阴道蓝紫色结节 原理不同

①绒癌：经血管转移至阴道致阴道出血坏死

②侵袭性葡萄胎：绒毛入血作为栓子、经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死（绒毛无法继续生长）转移:癌细胞入血后在另外一个地方继续生长



图 14-12　子宫绒毛膜癌
癌组织位于子宫底部，呈暗紫红色，结节状，可见出血坏死。

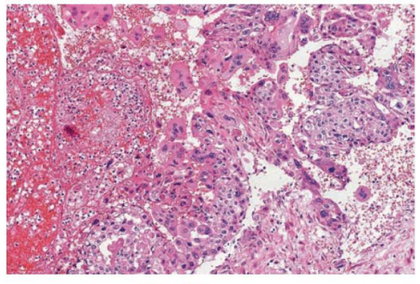


图 14-13　绒毛膜癌
由细胞滋养层和合体滋养层两种瘤细胞组成，细胞异型性明显，肿瘤内无间质和血管。

(13) 理顺知识点：
葡萄胎和绒毛膜癌来源于两种细胞，分别是合体滋养层细胞和细胞滋养层细胞。两者区别在于异型增生和坏死出血的程度不同。

VS 胎盘部位滋养细胞肿瘤来源于单一的中间型滋养细胞。

(14) 理顺知识点：
理解恶性/侵袭性葡萄胎被称为交界性肿瘤。

①.其存在绒毛结构，并且几乎不发生转移，类似于良性肿瘤；

②.其水泡状绒毛侵犯子宫肌层和/或血管，表现类似恶性肿瘤，并且其绒毛侵犯血管内时，可作为不溶于循环血液中的栓子，经血管至阴道造成栓塞，引起阴道出血坏死，形成蓝紫色结节。即“能侵犯不转移”

故其生物学行为介于良恶性之间，称为交界性肿瘤。

(15) 理顺知识点：
肝、肺都是体内血液循环量很大的器官。肝脏的门静脉回流消化道的血液，因此消化道肿瘤易转移至肝脏，形成转移性肝癌。

对应的绒毛膜癌易侵犯静脉，随静脉回流入右心，随后转移至肺。

(16) 理顺知识点：
绒毛膜癌处于宿主的血液中，化疗药物易到达，因此绒毛膜癌的化疗药物治愈率接近100%。

规律：血供好的肿瘤化疗效果好，血供差的肿瘤化疗效果差。如食管的鳞癌，通常选择放疗，因鳞癌化疗药物难以抵达，反之，腺癌通常化疗效果较好。

（二）葡萄胎

风湿病

1.胎盘绒毛因间质高度**水肿**、**黏液样变性**而增大，呈葡萄状，称为水泡状胎块（无血管-透明），绒毛**间质内血管消失**、或有少量无功能毛细血管（内无红细胞），**滋养层细胞异型增生**（风到这里就是粘、粘住过客的葡萄。这节课后你将失去对巧克力/葡萄/橘子的兴趣）

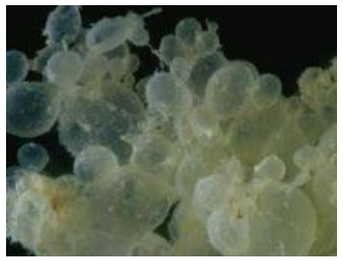




图 14-10　葡萄胎
子宫体积增大，子宫腔内充满大小不等的透明水泡。

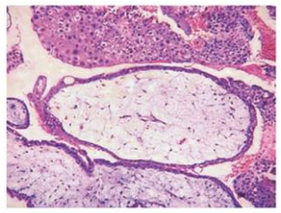
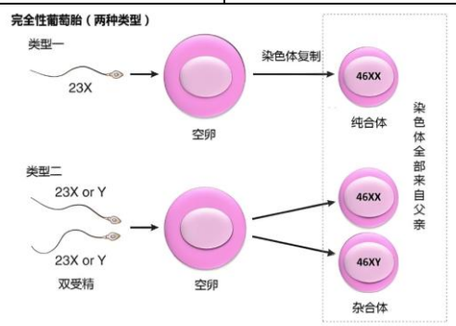


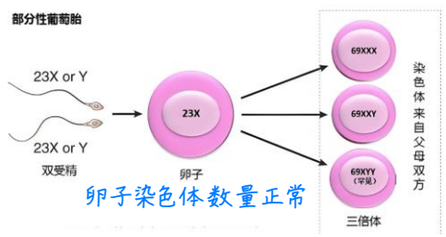
图 14-11　完全性葡萄胎
胎盘绒毛显著肿大，间质水肿，血管消失，滋养层细胞明显增生。

2.完全性 VS 部分性葡萄胎

完全性葡萄胎完全 2 个字	部分性葡萄胎不完全 3 个字
所有绒毛呈葡萄状	部分绒毛呈葡萄状
①主要：一个精子 23X 结合缺乏染色体的空卵精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合缺乏染色体的空卵少见	①一个双倍体精子 46XY 结合染色体数量正常的卵细胞 23X 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合染色体数量正常的卵细胞 23X
双倍体核型：46XX（主要）、46XY	三倍体核型：69XXX、69XXY、69XYY
染色体全部来自父亲	染色体来自父母双方
无胎儿组织	可有胎儿组织
无 p57 核染色	有 p57 核染色

P57是正常核染色现象





卵子染色体数量正常

⑰ 理顺知识点：
男方提供了一个精子，染色体的核型是23X；女方提供一个无染色体的空卵子。两者结合后，精子自行复制，形成46XX。此时为完全性葡萄胎的最常见原因。

此外，还可以是男方提供两个精子，即23X或23Y，女方提供一个无染色体的卵子，双受精后形成46XX或46XY，以46XX为主。

即完全性葡萄胎中染色体一定全部来源于父亲，母亲只提供了一个空卵（无染色体）

⑱ 理顺知识点：
男方提供了一个双倍体精子，染色体的核型是46XY或46XX。女方提供了一个卵子，核型为23X。两者结合后，形成69XXX或69XXY。此时为不完全性葡萄胎的最常见原因。（女方卵子正常，男方提供的精子没有正常完成减数分裂，仍然为二倍体精子）

此外，还可以是男方提供两个精子，即23X或23Y，女方提供一个卵子，即23X，双受精后形成69XXX、69XXY、69XYY（少见）。

即不完全性葡萄胎中染色体来自于父母双方。

（三）胎盘部位滋养细胞肿瘤（恶性）

胎盘内分泌功能：①hCG ②人绒毛膜促生长激素/人绒毛膜催乳素 ③雌激素 ④孕激素

①多数人胎盘催乳素 hPL+、少数 hCG+

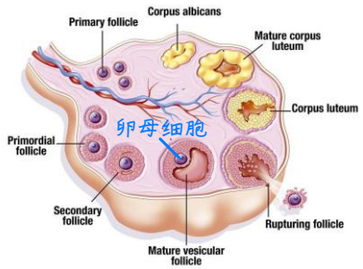
②**单一**的中间型滋养细胞（VS 绒癌为两种细胞）

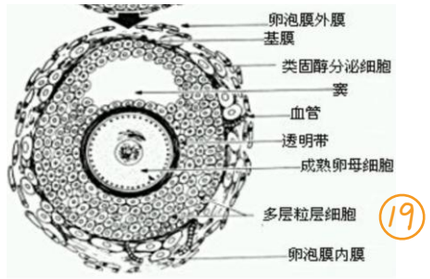
③无绒毛，可侵犯肌层、可转移

④一般无明显出血、坏死 VS 绒癌

四、卵巢肿瘤

卵泡包括中央的卵母细胞（实质）和周围的卵泡细胞（间质）（性索间质）





⑲

上皮性肿瘤（最常见）	浆液性/黏液性囊腺瘤/囊腺癌等
由卵母细胞发生的为**生殖细胞肿瘤**（膜内无鸡胚）	畸胎瘤（成熟畸胎瘤为良性）、无性细胞瘤（恶性）、内胚窦瘤/卵黄囊瘤、胚胎性癌、绒毛膜癌（生殖细胞来源的肿瘤多是恶性） ⑳
由卵泡细胞发生的为**性索间质肿瘤**（支持一粒卵泡）	粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤（恶性）、卵泡膜细胞瘤（良性）、支持-间质细胞瘤（靠近生殖细胞一偏恶性，远离生殖细胞一良性）（主要发生在睾丸、肿瘤分泌雄激素）

除开卵母都是卵泡细胞

1.上皮性肿瘤举例

浆液性肿瘤（发病率高）	黏液性肿瘤
囊腔内含清亮囊液和实性结节	多个囊腔、内含黏稠囊液和实性结节
乳头多见（恶性者更多）双儒将	乳头少见
累及双侧卵巢多见	累及单侧卵巢多见
恶性即**浆液性囊腺癌**：癌细胞浸润间质、㉑ **砂粒体/钙化小体** 又是乳头又是癌（甲状腺乳头状癌） 脑膜瘤也可有砂粒体	恶性即黏液性囊腺癌：癌细胞浸润间质（子宫内膜异型增生VS子宫内膜癌:癌细胞有无浸润子宫内膜间质）

①浆液性肿瘤乳头多见 ②必须是癌

注意：卵巢黏液性癌可为原发（本节所学，累及单侧卵巢多见）

可为继发（胃肠黏液癌尤其胃印戒细胞癌种植性转移至卵巢，累及双侧卵巢多见）

双侧卵巢的恶性肿瘤首先考虑 **Krukenberg 瘤**（胃癌转移到卵巢）

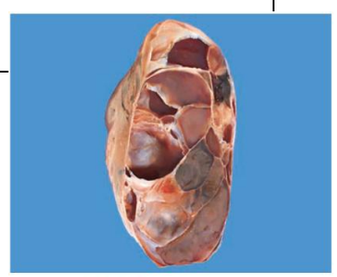


图 14-17　卵巢黏液性囊腺瘤
肿瘤表面光滑，包膜完整，由多个大小不一的囊腔组成，其中某些腔内充满富于糖蛋白的黏稠液体。

⑲ 理顺知识点：
卵泡的结构，最中心为卵母细胞，发生的是生殖细胞肿瘤。
外周为卵泡细胞，最外层为卵泡膜细胞，此时发生性索间质肿瘤。
来自上皮（以前认为是卵巢上皮，现在更多认为来自输卵管上皮）的是上皮性肿瘤。（最常见）

掌握大分型，再记忆不同分型中的病理类型。且越靠近卵泡中心，恶性程度就越高。（规律）

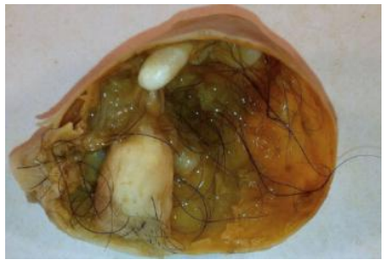
⑳ 理顺知识点：
绒毛膜癌既可以来源于滋养层细胞，也可来源于卵母生殖细胞。

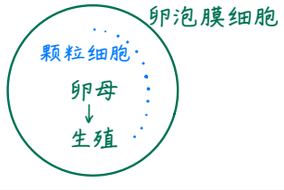
㉑ 理顺知识点：
砂粒体样钙化多见于恶性者，浸润间质多见于恶性者。

2.生殖细胞肿瘤举例 膜内无鸡胚

畸胎瘤	内胚窦瘤/卵黄囊瘤
良性（成熟懂事） **恶性**（未成熟） 22	高度**恶性**
多含≥2 个胚层成分（**各种组织均有**如皮肤、毛囊、脂肪） 人体有3个胚层:外胚层、中胚层、内胚层 良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿 **恶性**：**未成熟**原始神经管和菊形团、骨和软骨等 （复习：小细胞肺癌可围绕小血管形成假菊形团结构）	甲胎蛋白 **AFP** 升高 **疏网状结构** 23 **S-D 小体** **嗜酸性小体** ASSS

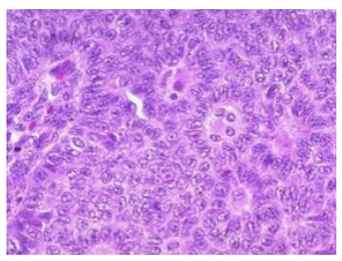
存在幼稚肝细胞,AFP升高时要排除生殖细胞肿瘤,才能确诊肝癌

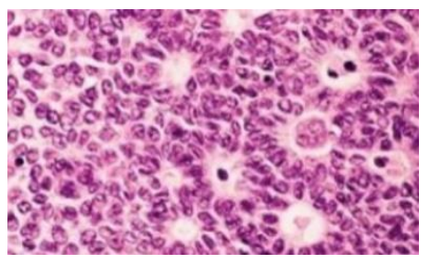




3.性索间质肿瘤举例

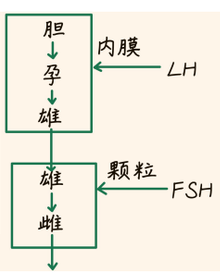
粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤	卵泡膜细胞瘤
低度**恶性**	**良性** 卵泡膜细胞离卵母细胞远
核沟 肿瘤分泌**雌**激素　不能套用双重细胞学说	肿瘤分泌**雌**激素 用最终是雌激素理解
核沟、咖啡豆样，Call-Exner 小体 粒粒咖啡豆 coffee （复习：甲状腺乳头状癌也有核沟）①①①①	细胞质富含脂肪（空泡状） 卵脂





小凯笔记自行整理:双重细胞学说

调节	ttsx	卵巢
LH	合成雄激素	内泡膜细胞
FSH flower	上述细胞分泌的 芳香化酶 雄激素→雌激素	颗粒细胞



22 理顺知识点:
畸胎瘤的良恶性由其组织成分决定。若以成熟组织为主,则为良性畸胎瘤;若以未成熟组织为主,则为恶性畸胎瘤。

23 内胚窦瘤/卵黄囊瘤,因组织形态与小鼠胎盘的结构很相似而得名,多发生在30岁以下妇女,是婴幼儿生殖细胞肿瘤中最常见的类型,生物学行为呈高度恶性。
大多数患者血清AFP水平较高,故AFP升高时需要排除妊娠、生殖细胞肿瘤的影响,才能诊断为原发性肝细胞癌HCC。

镜下可见多种组织形态:
①.疏网状结构:是最常见的形态,相互交通的间隙形成微囊和乳头,内衬立方或扁平上皮,背景呈黏液状。
②.S-D小体:由含有肾小球样结构的微囊构成,中央有一纤维血管轴心
③.多泡性卵黄囊结构
④.细胞外嗜酸性小体:也是常见的特征性结构。

淀粉样变性：甲状腺髓样癌、I工型糖尿病、前列腺增生

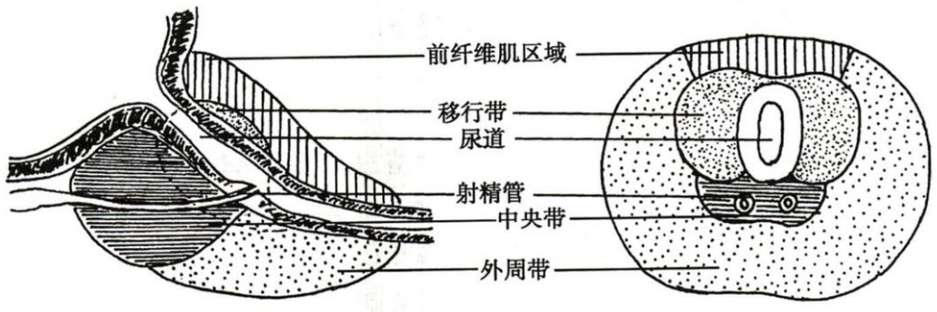
五、前列腺增生 VS 前列腺癌

前列腺增生不会变成前列腺癌
痔疮不会变成大肠癌

（与雄激素有关）

前列腺增生/肥大	前列腺癌
好发于**移行带**	好发于**外周带** 曾毅爱粥
淀粉小体 qian-dian	①**缺失基底细胞** (24) ②可经椎旁静脉转移至脊椎**骨**等 中线结构 ③**PSA**、**酸**性磷酸酶 摸前列腺好酸爽 前列腺特异抗原

前列腺治疗：去势治疗：割睾丸-无法手术时用来治疗前列腺癌
非那雄胺—抑制5α还原酶阻止双氢睾酮生成-治疗前列腺增生



(24) VS 乳腺癌缺失肌上皮细胞(与乳腺硬化性腺病鉴别)
(乳腺的肌上皮细胞参与射乳反射,其对缩宫素/催产素OT敏感,即肌上皮收缩,促进乳汁的排出。)

真题解析·生殖系统疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N164 X 良性畸胎瘤内可出现的组织有
A.脑组织
B.软骨组织
C.甲状腺组织
D.皮肤及其附属器

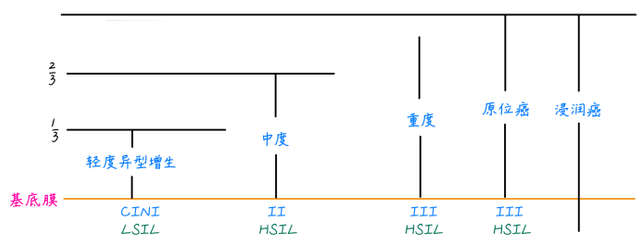
2. 2015N54 A 与子宫内膜癌关系不密切的子宫内膜变化是
A.单纯性增生
B.复杂性增生
（增生不伴异型增生）
C.非典型增生=不典型增生=异型增生
D.增殖期子宫内膜 月经周期正常生理现象

3. 2016N54 A 以下选项中，不属于绒毛膜上皮癌的病理特征是
A.高度水肿的绒毛
B.出血坏死明显
C.没有肿瘤间质成分
D.肿瘤细胞高度异型

答案：1-3 ABCD D A

4.2017N39 A 在子宫肌层内发现水肿的绒毛，诊断为
A.葡萄胎 良性葡萄胎不侵入肌层
B.绒毛状腺瘤
C.绒毛膜上皮癌 绒癌没有绒毛
D.侵袭性葡萄胎

5.2017N151 X 以下病变中，属于子宫颈 CIN III的有
A.轻度异型增生
B.中度异型增生
C.重度异型增生
D.原位癌



6.2019N39 A 在下列描述中，子宫颈癌I期的是
A.癌细胞尚未突破基底膜 原位癌
B.癌细胞浸润并局限于子宫颈内
C.癌细胞分化较成熟
D.癌细胞浸润范围超过子宫颈

7.2019N149 X 绒毛膜癌区别于恶性葡萄胎的病理特点有
A.呈浸润性生长 共性
B.出血、坏死更明显
C.滋养细胞增生 共性
D.无绒毛和水泡形成

8.2020N38 A 在子宫颈活检组织中，见异型上皮细胞累及全层并突破基底膜向下生长 3mm，应诊断为
A.子宫颈原位癌
B.子宫颈原位癌累及腺体
C.子宫颈早期浸润癌
D.子宫颈浸润癌

以题带动
知识点复习

9.2021N39 A 绒毛膜癌的组织学特点是
A.肿瘤本身无间质血管
B.癌细胞形成绒毛结构
C.癌组织出血坏死不明显
D.由分化不良的细胞滋养层细胞构成 两种滋养层细胞

10.2022N32 A 前列腺癌血道转移最常见的部位是
A.肝
B.肾
C.骨
D.肺

答案：4-10 D CD B BD C A C

11. 2022N37 A 高危型 HPV 感染可引起宫颈癌的重要机制是

A.病毒能编码 E_2 和 E_3 蛋白

B.病毒能编码 E_4 和 E_5 蛋白

C.病毒能编码 E_6 和 E_7 蛋白 5678

D.病毒能编码 E_8 和 E_9 蛋白

12. 2024N151 X 关于完全性葡萄胎的叙述，正确的有

A.均为男性遗传起源

B.核型为二倍体

C.可以有胎儿存在

D.水肿的绒毛间质内血管增生

完全性葡萄胎完全 2 个字	部分性葡萄胎不完全 3 个字
所有绒毛呈葡萄状	部分绒毛呈葡萄状
①主要：一个精子 23X 结合缺乏染色体的空卵精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合缺乏染色体的空卵少见	①一个双倍体精子 46XY 结合染色体数量正常的卵细胞 23X 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合染色体数量正常的卵细胞 23X
双倍体核型：46XX（主要）、46XY	三倍体核型：69XXX、69XXY、69XYY
染色体全部来自父亲	染色体来自父母双方
无胎儿组织	可有胎儿组织
无 p57 核染色	有 p57 核染色

13. 2025N40 A 关于绒毛膜癌病理学特点的叙述，正确的是

A.肉眼观，肿瘤呈~~灰白色~~红色、质硬

B.由分化不良的两种滋养层细胞组成

C.肿瘤血管丰富，出血、坏死明显 没有血管

D.部分癌细胞形成绒毛和水泡状结构 没有绒毛

思维导图 • 生殖系统疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：11-13 C AB B